

X 侵襲または呼吸器症状の出現・悪化から1週間以内の発症である。

O 胸水・無気肺・結節のみでは説明できない両側性の肺陰影がある。

X 心不全や輸液過剰では説明が困難な肺水腫であり、可能であれば心エコーなどでの評価が望ましいとされている(右心カテーテル検査は必須ではない)。

X PEEP 5 cmH₂O 以上での酸素化障害 (PaO₂/FiO₂ 300 mmHg 以下) が診断基準の一項目である。

X ベルリン定義以前の American-European Consensus Conference (AECC) 基準は PaO₂/FiO₂ 201~300 mmHg を acute lung injury (ALI)、PaO₂/FiO₂ 200 mmHg 以下を ARDS とする分類であった。

X ベルリン定義では PaO₂/FiO₂ 201~300 mmHg が軽症、101~200 mmHg が中等症、100 mmHg 以下が重症となり、ALI の分類は廃止された。

O 小児では片側性の肺実質障害を示す画像所見でも ARDS と認められる。

X 上気道閉塞の遷延が予想される、鎮静・鎮痛薬のために循環動態不安定となる、リハビリが遅延するなどの一部の場合を除き、全例への早期気管切開は推奨されない。

O 意識障害や循環不全の患者では挿管管理を考慮する。

X 人工呼吸器関連肺損傷 (ventilator associated lung injury: VALI) を避けるため、1回換気量とプラトー圧を制限する肺保護換気が推奨される。1回換気量は、実測体重ではなく、身長から計算される予測体重を用いて6~8 mL/kg に設定する(低容量換気)。